



**GAMBARAN TINGKAT STRES DAN KEPATUHAN PENGOBATAN
PADA PASIEN HIPERTENSI DALAM PROGRAM PTM
DI PUSKESMAS RIMBO TENGAH KAB BUNGO**

Comment [i-[1]: Pd latar belakang tdk menyentuh ttg ini. Apakah fokus PTM dlm penelitian?

**TUGAS AKHIR
KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH**

OLEH

**YUSMALINDA
NIM. 2514201631**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN IBU JAMBI
YAYASAN HARAPAN IBU JAMBI
TAHUN 2026**



**GAMBARAN TINGKAT STRES DAN KEPATUHAN PENGOBATAN
PADA PASIEN HIPERTENSI DALAM PROGRAM PTM
DI PUSKESMAS RIMBO TENGAH KAB BUNGO**

**Tugas Akhir Ini Diajukan
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
SARJANA KEPERAWATAN**

OLEH

**YUSMALINDA
NIM. 2514201631**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HARAPAN IBU JAMBI
YAYASAN HARAPAN IBU JAMBI
TAHUN 2026**

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yusmalinda

NIM 2514201631

Program Studi : Ilmu Keperawatan

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul "Gambaran Tingkat Stres dan Kepatuhan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi dalam Program PTM di Puskesmas Muara Tembesi" adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip secara langsung maupun tidak langsung ataupun dirujuk, adalah benar.

Jambi, April 2026

YUSMALINDA
NIM. 2514201631

PERNYATAAN PERSETUJUAN

**Skripsi ini telah disetujui, diperiksa dan siap dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu kesehatan Harapan Ibu Jambi**

Jambi, April 2026

Mengetahui,

Ka. Prodi Ilmu Keperawatan

(Ns. Diah Merdekawati, M. Kep)

Menyetujui,

Pembimbing

(Ns. Isti Harkomah, M. Kep)

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN
PEMINATAN KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH
Tugas Akhir, April 2026

Yusmalinda

Gambaran Tingkat Stres dan Kepatuhan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi dalam Program PTM di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo"

xvi + 42 halaman, 5 tabel

ABSTRAK

Latar Belakang Hipertensi merupakan penyakit tidak menular yang membutuhkan pengobatan jangka panjang dan pengelolaan yang berkelanjutan. Kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan menjadi faktor penting dalam pengendalian tekanan darah. Namun, dalam praktiknya masih banyak pasien hipertensi yang tidak patuh menjalani terapi pengobatan. **Tujuan** Penelitian untuk mengetahui gambaran tingkat stres dan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi dalam program Penyakit Tidak Menular (PTM) di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo

Metode Penelitian ini menggunakan desain deskriptif .Penelitian dilaksanakan di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo pada tanggal 02 s.d 07 Januari 2026. Populasi penelitian adalah seluruh pasien hipertensi dalam program PTM sebanyak 600 orang. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan kuesioner tingkat stres dan kuesioner kepatuhan pengobatan. Data dianalisis secara univariat dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden mengalami tingkat stres kategori sedang sebanyak 17 orang (56,7%), Tingkat kepatuhan pengobatan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kepatuhan tinggi sebanyak 14 orang (46,7%),

Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hipertensi memiliki tingkat stres kategori sedang dan kepatuhan pengobatan kategori tinggi. Oleh karena itu, Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo diharapkan dapat meningkatkan edukasi kesehatan, konseling, serta pemantauan kepatuhan pengobatan secara berkala guna membantu pasien mengelola stres dan meningkatkan keberhasilan pengendalian tekanan darah. Puskesmas meningkatkan pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi melalui edukasi rutin mengenai pentingnya kepatuhan pengobatan dan pengelolaan stres sebagai bagian dari Program Penyakit Tidak Menular (PTM).

Daftar pustaka: 28 (2013–2025).

Kata kunci: Hipertensi; stres; kepatuhan; pengobatan; PTM

Comment [i-[2]: hapus

Comment [i-[3]: sesuaikan dgn SK

Comment [i-[4]: bhsa asing,
dimiringkan

Comment [i-[5]: tiskan nama
instrumennya!

Comment [i-[6]: hapus

Comment [i-[7]: hapus

Comment [i-[8]: kepatuhan_pengobatan

Comment [i-[9]: hapus

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yusmalinda
Tempat Tanggal Lahir : Ampalu, 12 desember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sungai Gambir, RT 007 Desa Sungai Mengkuang
No HP : -
Email : yusmalinda1212@gmail.com
Nama Ayah : Syahbuddin(Alm)
Nama Ibu : Manis

Riwayat Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 002 Air Molek I
Sekolah Menengah Pertama : SMP N 3 Pasir Penyu
Sekolah Menengah Umum : SMU N 2 Pasir Penyu Indragiri Hulu
D3 Keperawatan : AKPER SETIH SETIO BUNGO
S1 Keperawatan : STIKES HI JAMBI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan pembuatan Tugas Akhir ini yang berjudul **“Gambaran Tingkat Stres dan Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Hipertensi dalam Program PTM di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Shalallahu Alaihi Wa Sallam, yang telah mengajarkan dan membimbing umatnya dari umat yang tidak mengetahui apa-apa menuju umat yang berbudi luhur dan bermoral serta menjadikan umatnya senantiasa bertaqwa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.

Comment [i-[10]: spasi 2

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Saprimail Harahap, M. Kes, selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi.
2. Ns. Diah Merdekawati, M. Kep, selaku Ketua Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi.
3. Ibu Ns. Isti Harkomah, M.Kep, selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing, memberi petunjuk, dorongan, serta saran-saran dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
4. Bapak / Ibu dosen dan staf Administrasi Program Studi Ilmu Keperawatan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Harapan Ibu Jambi.
5. Kepala dan seluruh tenaga kesehatan **Puskesmas Rimbo Tengah** Kab Bungo yang telah memberikan izin serta membantu penulis selama proses penelitian berlangsung

Meskipun penulis menyadari telah berusaha semaksimal mungkin dalam penulisan tugas akhir ini namun kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala, karena itu penulis sangat menyadari tugas akhir ini banyak kekurangan dan penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini.

Oleh karena itu penulis berharap tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, Aamiin

Jambi, April 2026

JUDUL

Gambaran Tingkat Stres dan Kepatuhan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi dalam Program PTM di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat pada abad ke-21 karena tingkat morbiditas dan mortalitas yang tinggi secara global. WHO menyebutkan penyakit tidak menular merupakan penyakit penyebab kematian terbanyak di dunia. Kematian akibat penyakit tidak menular sekitar 36 juta penduduk tiap tahunnya. Berbagai jenis penyakit tidak menular yang diderita paling banyak oleh masyarakat antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi. Astuty (2021).

Comment [i-[11]: terlampau pjg:

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan tantangan kesehatan global yang serius karena seringkali tidak menunjukkan gejala namun dapat menyebabkan komplikasi fatal. *Organisasi Kesehatan Dunia* (WHO, 2023) menyatakan bahwa hipertensi adalah penyebab utama kematian dini di seluruh dunia, di mana diperkirakan 1,28 miliar orang dewasa berusia 30–79 tahun menderita penyakit ini. Masalah utamanya adalah hampir 46% orang dewasa dengan hipertensi tidak menyadari bahwa mereka memiliki kondisi tersebut.

Comment [i-[12]: (Astuty, 2021)

Di Indonesia, hipertensi juga menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius. Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, prevalensi hipertensi pada penduduk usia ≥ 18 tahun mencapai 34,1% berdasarkan hasil pengukuran tekanan darah. Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun

2023 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi nasional masih berada pada angka sekitar 30,8% pada penduduk dewasa. Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi masih menjadi salah satu penyakit kronis dengan beban kesehatan yang tinggi di masyarakat (Kementerian Kesehatan RI, 2018; Kementerian Kesehatan RI, 2023).

Tingkat provinsi, data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 menunjukkan bahwa prevalensi hipertensi di Provinsi Jambi berada pada kisaran di atas 28%. Sementara itu, berdasarkan Laporan Riskesdas Provinsi Jambi tahun 2018, prevalensi hipertensi yang didiagnosis tenaga kesehatan atau sedang minum obat di Kabupaten Bungo mencapai 10,64% pada penduduk usia ≥ 18 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa hipertensi juga menjadi masalah kesehatan yang nyata di Kabupaten Bungo, termasuk di wilayah kerja Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo sebagai lokasi penelitian (Kementerian Kesehatan RI, 2018).

Data terbaru dari Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 juga menunjukkan bahwa depresi masih menjadi salah satu masalah kesehatan mental di masyarakat. Prevalensi depresi di Indonesia pada tahun 2023 tercatat sekitar 1,4% dari penduduk usia ≥ 15 tahun, dengan angka tertinggi pada kelompok usia muda. Kondisi depresi dan tekanan psikologis tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup serta perilaku kesehatan seseorang, termasuk dalam kepatuhan menjalani terapi pengobatan pada penyakit kronis seperti hipertensi. (<https://dinkes.depok.go.id>)

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pengendalian hipertensi sangat dipengaruhi oleh kepatuhan pasien dalam menjalani terapi. Penelitian Burnier dan Egan (2019) menyatakan bahwa ketidakpatuhan terhadap pengobatan antihipertensi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pengendalian tekanan

Comment [i-13]: Tuliskan nama institusi dan thnnya saja, bkn linknya!

darah pada pasien hipertensi. Penelitian Xu et al.(2022) juga menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti stres dan depresi berhubungan signifikan dengan rendahnya kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Selain itu, penelitian Saputri, Malasari, dan Rahman (2024) menemukan bahwa pasien hipertensi dengan tingkat stres yang tinggi memiliki kecenderungan kepatuhan minum obat yang lebih rendah dibandingkan pasien dengan tingkat stres yang lebih ringan.

Hipertensi adalah kenaikan tekanan darah baik sistolik maupun diastolic. Hipertensi dikenal dengan the heterogeneous group of disease dan the killer disease. Hipertensi merupakan faktor risiko yang menyebabkan kematian dini, serta terjadinya gagal jantung dan penyakit gangguan otak. Faktor usia, sosial dan ekonomi dapat teraspek hipertensi. Dengan bertambahnya usia, risiko hipertensi menjadi lebih besar, ini disebabkan adanya perubahan struktur pada pembuluh darah besar sehingga lumen menjadi sempit dan dinding pembuluh darah menjadi lebih kaku dan tekanan darah sistolik meningkat. Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk memberikan penyuluhan dan mengedukasi masyarakat tentang penyakit hipertensi. Metode yang dilakukan dengan mengunjungi serta memberikan edukasi disertai diskusi kepada masyarakat dan melakukan pemeriksaan tekanan darah. Rahayu (2021).

Kepatuhan pengobatan merupakan perilaku kesehatan yang sangat penting dalam keberhasilan terapi penyakit kronis., kepatuhan pengobatan adalah tingkat kesesuaian perilaku pasien dalam mengikuti anjuran tenaga kesehatan, termasuk dalam mengonsumsi obat secara teratur, menjalani kontrol kesehatan, serta menerapkan gaya hidup sehat. Menurut Notoatmodjo (2018).

Comment [i-14]: Ditulis pada awal kata atau prgrf

Menurut Stuart (2016), stres merupakan respon individu terhadap tekanan atau tuntutan yang dirasakan melebihi kemampuan coping yang dimiliki seseorang. Pada pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, stres dapat muncul akibat kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan, perubahan gaya hidup, serta tuntutan menjalani pengobatan jangka panjang. Kondisi stres yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisiologis pasien, termasuk peningkatan tekanan darah serta perilaku kesehatan pasien. Penelitian Xu et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti stres dan depresi memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Selain itu, penelitian Saputri, Malasari, dan Rahman (2024) juga menemukan bahwa pasien hipertensi dengan tingkat stres yang lebih tinggi cenderung memiliki kepatuhan minum obat yang lebih rendah dibandingkan pasien dengan tingkat stres ringan. Penelitian Burnier dan Egan (2019) juga menyatakan bahwa faktor psikologis, termasuk stres, dapat memengaruhi perilaku pasien dalam menjalani terapi antihipertensi secara teratur.

Kepatuhan pengobatan merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan terapi penyakit kronis. Menurut Notoatmodjo (2018), kepatuhan pengobatan adalah tingkat kesesuaian perilaku pasien dalam mengikuti anjuran tenaga kesehatan, termasuk dalam mengonsumsi obat secara teratur, menjalani kontrol kesehatan, serta menerapkan gaya hidup sehat. Kepatuhan pasien dalam menjalani pengobatan sangat berperan dalam mengendalikan tekanan darah dan mencegah komplikasi pada penderita hipertensi. Penelitian Burnier dan Egan (2019) menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap pengobatan antihipertensi merupakan salah satu penyebab utama kegagalan pengendalian tekanan darah pada pasien

Comment [i-[15]: Apa ada notoadmojo menjelaskan ttg kepatuhan pengobatan?

hipertensi. Selain itu, penelitian Putra dan Arisudhana (2021) juga menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang memiliki tingkat kepatuhan pengobatan yang baik cenderung memiliki kontrol tekanan darah yang lebih stabil dibandingkan pasien yang tidak patuh terhadap terapi. Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pengobatan merupakan komponen penting dalam pengelolaan hipertensi secara optimal.

Dampak Tingkat Stres dan Kepatuhan Pengobatan pada Pasien Hipertensi terhadap kondisi fisiologis pasien, tingkat stres yang tinggi pada pasien hipertensi dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah secara signifikan. Hal ini terjadi karena stres memicu pelepasan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang dapat menyempitkan pembuluh darah. Jika kondisi ini berlangsung terus-menerus dan tidak diimbangi dengan kepatuhan pengobatan yang baik, maka risiko komplikasi seperti stroke, penyakit jantung, dan gagal ginjal akan meningkat, terhadap kepatuhan pengobatan Stres yang dialami pasien dapat menurunkan tingkat kepatuhan dalam menjalani pengobatan. Pasien yang mengalami stres cenderung: lupa mengonsumsi obat, tidak rutin melakukan kontrol ke fasilitas kesehatan, menghentikan pengobatan tanpa anjuran tenaga medis.

Pasien dengan tingkat stres yang rendah cenderung lebih patuh terhadap pengobatan, sehingga pengendalian tekanan darah menjadi lebih optimal., terhadap keberhasilan program PTM. Dalam Program Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM), tingkat stres dan kepatuhan pengobatan menjadi indikator penting keberhasilan program. Tingkat stres yang tinggi dan kepatuhan yang rendah dapat menghambat pencapaian tujuan program, yaitu pengendalian tekanan darah dan pencegahan komplikasi. Sebaliknya, jika pasien memiliki tingkat stres yang terkendali dan patuh

terhadap pengobatan, maka program PTM akan berjalan lebih efektif.

Pasien hipertensi dengan tingkat stres tinggi dan kepatuhan rendah cenderung memiliki kualitas hidup yang menurun, seperti: Mudah lelah, gangguan tidur, kecemasan berlebih, penurunan produktivitas, sedangkan pasien yang mampu mengelola stres dan patuh dalam pengobatan umumnya memiliki kualitas hidup yang lebih baik dan stabil, terhadap beban pelayanan kesehatan. Ketidakepatuhan pengobatan yang dipengaruhi oleh stres dapat meningkatkan angka kunjungan ulang, rawat inap, serta biaya pengobatan. Hal ini tentu menjadi beban tambahan bagi fasilitas kesehatan, termasuk Puskesmas dalam pelaksanaan Program PTM.

Tingkat stres dan ketidakepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi tidak segera ditangani, maka perawat memiliki peran penting sebagai upaya pencegahan dampak yang lebih buruk, yaitu, sebagai Edukator (Pendidik) Perawat berperan memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai, Edukasi ini penting agar pasien memiliki pemahaman yang baik dan dapat mengubah perilaku kesehatannya, Sebagai Konselor Perawat membantu pasien dalam mengidentifikasi sumber stres serta memberikan dukungan psikologis. Jika masalah tidak diatasi, perawat perlu: Caregiver (Pemberi Asuhan Keperawatan) Sebagai Koordinator Pelayanan Kesehatan Sebagai Motivator Sebagai Advokat Pasien.

Berdasarkan hasil survei awal pada tanggal 02 Januari yang dilakukan terhadap 10 responden pasien hipertensi di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo, ditemukan bahwa masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengelolaan penyakit, khususnya terkait tingkat stres dan kepatuhan pengobatan, sebanyak 5 orang menunjukkan tingkat kepatuhan pengobatan yang rendah hal ini disebabkan karena responden sering lupa

mengonsumsi obat, tidak rutin melakukan kontrol ke puskesmas, serta menghentikan pengobatan ketika merasa kondisi tubuh sudah membaik. Selain itu, sebagian dari mereka juga mengaku kurang memahami pentingnya pengobatan jangka panjang pada penyakit hipertensi, sehingga kepatuhan dalam menjalani terapi masih rendah. Sebanyak 3 orang responden memiliki tingkat kepatuhan sedang. Responden dalam kelompok ini pada dasarnya sudah berusaha menjalani pengobatan, seperti minum obat secara teratur dan melakukan kontrol, namun masih belum konsisten. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesibukan sehari-hari, rasa bosan dalam menjalani pengobatan jangka panjang, serta adanya perasaan khawatir dan cemas terhadap kondisi penyakit yang diderita. Sedangkan 2 orang responden menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi. Responden ini secara rutin mengonsumsi obat sesuai anjuran tenaga kesehatan dan melakukan kontrol secara berkala. Hal ini didukung oleh kesadaran yang baik terhadap pentingnya menjaga kesehatan, serta adanya motivasi untuk mencegah komplikasi yang dapat terjadi akibat hipertensi. Selain itu, responden juga mampu mengelola stres dengan lebih baik sehingga tidak mengganggu kepatuhan dalam menjalani pengobatan.

Selain masalah kepatuhan, dari hasil wawancara juga ditemukan bahwa sebagian responden mengalami kondisi psikologis berupa stres, yang ditandai dengan perasaan cemas, mudah lelah, serta kekhawatiran terhadap penyakit yang diderita. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek psikologis memiliki peran penting dalam memengaruhi perilaku kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi.

Berdasarkan data awal tersebut, terlihat bahwa masih terdapat keterkaitan antara tingkat stres dengan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. Oleh karena

Comment [i-[16]: Cek kembali apakah ini gejala stres?

itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui gambaran tingkat stres dan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi dalam Program PTM di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan peristiwa tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
“Bagaimanakah gambaran tingkat stres dan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi dalam program PTM di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo?”

2. Tujuan

a. Tujuan Umum

Diketahui gambaran tingkat stres dan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi dalam program Penyakit Tidak Menular (PTM) di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo sebagai dasar pendekatan asuhan keperawatan jiwa di pelayanan kesehatan primer.

b. Tujuan Khusus

1. Diketahui karakteristik responden pasien hipertensi (usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan lama menderita hipertensi) dalam program Penyakit Tidak Menular (PTM)
2. Diketahui gambaran stres pada pasien hipertensi dalam program Penyakit Tidak Menular (PTM)
3. Diketahui gambaran kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi dalam program Penyakit Tidak Menular (PTM)

B. METODE

1. Desain Penelitian

Desain Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif.

2. Waktu dan Lokasi

Penelitian dilaksanakan di Wilayah Kerja Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo pada tanggal 02 s.d 07 Januari 2026.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien hipertensi yang mengikuti Program Penyakit Tidak Menular (PTM) di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo sebanyak 600 orang per tahun. Sampel penelitian berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* sesuai kriteria inklusi penelitian.dengan menggunakan total sampling.

4. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah Gambaran Tingkat Stres dan Kepatuhan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi.

5. Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga instrumen penelitian yaitu lembar karakteristik responden, kuesioner tingkat stres, dan kuesioner kepatuhan pengobatan.

a. Lembar Karakteristik Responden

Lembar karakteristik responden digunakan untuk mengidentifikasi data umum responden yang meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan terakhir, lama menderita hipertensi, dan kebiasaan kontrol ke puskesmas. Data ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden dalam penelitian.

b. Kuesioner Tingkat Stres

Instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat stres pada pasien hipertensi berupa kuesioner tingkat stres yang disusun berdasarkan konsep stres dalam keperawatan jiwa menurut Stuart (2016). Kuesioner ini terdiri dari **10 pertanyaan** yang menggambarkan kondisi emosional dan psikologis responden dalam menghadapi penyakit hipertensi.

Setiap pertanyaan menggunakan skala penilaian **0–3** dengan ketentuan sebagai berikut:

0 = Tidak pernah

1 = Kadang-kadang

2 = Sering

3 = Sangat sering

Skor total diperoleh dengan menjumlahkan seluruh skor jawaban responden dengan rentang **0–30**.

Kategori tingkat stres ditentukan sebagai berikut:

0–10 = Stres ringan

11–20 = Stres sedang

21–30 = Stres berat

c. Kuesioner Kepatuhan Pengobatan

Instrumen kepatuhan pengobatan terdiri dari 8 pertanyaan yang menilai perilaku pasien dalam mengonsumsi obat antihipertensi. Instrumen ini mengacu pada konsep kepatuhan pengobatan menurut Notoatmodjo (2018).

Setiap pertanyaan menggunakan pilihan jawaban **Ya** dan **Tidak** dengan ketentuan

Comment [i-[17]: ???

skor sebagai berikut:

1. Jawaban patuh diberi skor **1**
2. Jawaban tidak patuh diberi skor **0**

Skor total berkisar antara **0–8**.

Kategori kepatuhan pengobatan ditentukan sebagai berikut:

1. Kepatuhan Tinggi : skor 7–8
2. Kepatuhan Sedang : skor 4–6
3. Kepatuhan Rendah : skor 0–3

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur.

7. Analisa Data

Data dianalisis secara Univariat dan disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase.

8. Etika Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian guna melindungi hak, martabat, dan kesejahteraan responden. Prinsip etika penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada prinsip etika penelitian kesehatan menurut Notoatmodjo (2018). Adapun prinsip etika yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Informed Consent (Persetujuan Setelah Penjelasan)

Sebelum pengumpulan data dilakukan, peneliti terlebih dahulu menjelaskan kepada calon responden mengenai tujuan penelitian, prosedur pelaksanaan, manfaat, serta kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Responden yang bersedia

berpartisipasi diminta untuk menandatangani lembar persetujuan (informed consent) sebagai bentuk persetujuan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

b. Respect for Human Dignity (Menghormati Martabat Responden)

Peneliti menghormati hak responden untuk menentukan sendiri keikutsertaannya dalam penelitian. Responden diberikan kebebasan untuk menolak atau mengundurkan diri dari penelitian kapan saja tanpa adanya konsekuensi terhadap pelayanan kesehatan yang diterimanya di puskesmas.

c. Anonymity (Tanpa Nama)

Penelitian ini tidak mencantumkan nama responden pada lembar kuesioner maupun dalam laporan hasil penelitian. Setiap responden diberikan kode tertentu untuk menjaga identitas dan kerahasiaannya.

d. Confidentiality (Kerahasiaan)

Semua informasi yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan penelitian. Data yang telah dikumpulkan tidak akan disebarluaskan kepada pihak lain dan akan disimpan secara aman oleh peneliti.

e. Beneficence (Prinsip Manfaat)

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi responden dan pihak puskesmas, khususnya dalam meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan jiwa pada pasien hipertensi. Penelitian ini tidak menimbulkan bahaya fisik maupun psikologis bagi responden karena hanya menggunakan kuesioner.

f. Justice (Keadilan)

Seluruh responden yang memenuhi kriteria memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam penelitian tanpa diskriminasi berdasarkan usia, jenis kelamin, pendidikan, atau status sosial.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hasil Distribusi Responden

Tabel 1.1 Karakteristik Responden

Karakteristik	Jumlah	Persentase %
Usia		
< 40 tahun	4	13,3
40–59 tahun	14	46,7
≥ 60 tahun	12	40
Jumlah	30	100
Jenis Kelamin		
Laki-laki	11	36,7
Perempuan	19	63,3
Jumlah	30	100
Pendidikan		
SD	8	26,7
SMP	7	23,3
SMA	10	33,3
Perguruan Tinggi	5	16,7
Jumlah	30	100
Lama Hipertensi		
< 1 tahun	6	20
1–5 tahun	14	46,7
> 5 tahun	10	33,3
Jumlah	30	100

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 40–59 tahun yaitu sebanyak 14 orang (46,7%), sedangkan paling sedikit pada usia < 40 tahun yaitu 4 orang (13,3%). Berdasarkan jenis kelamin, sebagian besar responden adalah perempuan sebanyak 19 orang (63,3%), sedangkan laki-laki sebanyak 11 orang (36,7%). Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA yaitu 10 orang (33,3%), dan paling sedikit berpendidikan perguruan tinggi sebanyak 5 orang (16,7%). Berdasarkan lama menderita hipertensi, sebagian besar

Comment [i-[18]: hapus

Comment [i-[19]: hapus

Comment [i-[20]: hapus

responden telah menderita hipertensi selama 1–5 tahun yaitu sebanyak 14 orang (46,7%),
sedangkan yang menderita < 1 tahun sebanyak 6 orang (20,0%).

Comment [i-[21]: hapus

b. **Distribusi Frekuensi Tingkat Stres**

Tabel 1.2 Berdasarkan tingkat stress

Tingkat Stres	Frekuensi	Persentase
Ringan	7	23.3%
Sedang	17	56.7 %
Berat	6	20.0 %
Total	30	100%

Comment [i-[22]: hapus smw % di blkg angka

Berdasarkan Tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami tingkat stres kategori **sedang** yaitu sebanyak 17 orang (56.7%). Responden dengan tingkat stres **ringan** sebanyak 7 orang (23.3%), sedangkan responden dengan tingkat stres **berat** sebanyak 6 Tabe;rang (20,0%). Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien hipertensi dalam Program PTM di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo masih mengalami tekanan psikologis pada tingkat sedang.

Comment [i-[23]: ckp data mayoritas saja

Comment [i-[24]: hapus

c. **Distribusi Frekuensi Kepatuhan Pengobatan**

Tabel 1.3 Berdasarkan Kepatuhan pengobatan

Kepatuhan Pengobatan	Frekuensi	Persentase
Tinggi	14	46.7 %
Sedang	9	30.0%
Rendah	7	23.3 %
Total	30	100%

Comment [i-[25]: komentar sm sprti pada point b. di atas!

Berdasarkan Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kepatuhan pengobatan kategori tinggi yaitu sebanyak 14 orang (46,7%). Responden dengan kepatuhan sedang sebanyak 9 orang (30.0%), sedangkan responden dengan kepatuhan rendah sebanyak 7 orang (23.3%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hipertensi telah menjalani pengobatan secara cukup teratur, meskipun masih

terdapat sebagian pasien dengan tingkat kepatuhan yang rendah.

B. Pembahasan

a. Karakteristik responden

1. Berdasarkan usia

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kelompok usia 40–59 tahun yaitu sebanyak 14 orang (46,7%). Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi lebih banyak terjadi pada kelompok usia dewasa hingga lanjut. Secara teori, peningkatan usia berhubungan erat dengan meningkatnya risiko hipertensi. Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan fisiologis pada pembuluh darah, seperti penurunan elastisitas dinding arteri dan peningkatan kekakuan pembuluh darah yang menyebabkan tekanan darah meningkat. Menurut Smeltzer & Bare (2013), semakin bertambah usia seseorang, maka risiko terjadinya hipertensi akan semakin tinggi akibat perubahan struktur dan fungsi sistem kardiovaskular.

Selain itu, pada usia dewasa akhir, individu juga mulai mengalami berbagai tekanan hidup seperti masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial yang dapat memicu stres, sehingga berpotensi memperburuk kondisi hipertensi.

2. Berdasarkan jenis kelamin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden adalah perempuan sebanyak 19 orang (63,3%). Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kecenderungan lebih tinggi mengalami hipertensi, terutama pada usia di atas 40 tahun. Secara fisiologis, perempuan yang telah memasuki masa menopause mengalami penurunan hormon estrogen yang

Comment [i-[26]: Tdk usah menggunaka sub bagian karakteristik!

Comment [i-[27]: Ganti dgn kategori usianya!

berperan dalam menjaga elastisitas pembuluh darah. Penurunan hormon ini menyebabkan peningkatan risiko terjadinya hipertensi. Menurut Black & Hawks (2014), setelah menopause, perempuan memiliki risiko hipertensi yang hampir sama bahkan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain faktor hormonal, perempuan juga cenderung lebih sensitif terhadap stres emosional yang dapat memengaruhi tekanan darah.

3. Berdasarkan pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas responden berpendidikan SMA sebanyak 10 orang (33,3%). Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam menerima dan memahami informasi kesehatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan, maka semakin baik pengetahuan seseorang tentang penyakit, pengobatan, serta pentingnya menjaga kesehatan. Menurut Notoatmodjo (2018), pendidikan merupakan faktor penting yang memengaruhi perilaku kesehatan seseorang, termasuk dalam kepatuhan menjalani pengobatan. Individu dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki kesadaran yang lebih baik terhadap pentingnya pengobatan dan pencegahan komplikasi hipertensi.

4. Berdasarkan lama menderita hipertensi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden telah menderita hipertensi selama 1–5 tahun yaitu sebanyak 14 orang (46,7%). Lama menderita hipertensi berpengaruh terhadap pengalaman dan adaptasi pasien dalam menghadapi penyakitnya. Pasien yang telah lama menderita hipertensi cenderung memiliki pengalaman lebih dalam mengelola penyakit, termasuk

dalam menjalani pengobatan dan mengontrol tekanan darah. Namun, di sisi lain, lamanya menderita penyakit juga dapat menimbulkan kejenuhan dalam menjalani terapi jangka panjang, sehingga berpotensi menurunkan kepatuhan pengobatan. Menurut Burnier & Egan (2019), pasien dengan penyakit kronis sering mengalami penurunan kepatuhan seiring lamanya durasi pengobatan akibat rasa bosan dan kelelahan psikologis.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa masih terdapat responden dengan pendidikan rendah, yang berpotensi memiliki keterbatasan dalam memahami pentingnya pengobatan jangka panjang.

b. Berdasarkan tingkat stres

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sebagian besar responden mengalami tingkat stres kategori sedang yaitu sebanyak 17 orang (56,7%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien hipertensi masih mengalami tekanan psikologis yang cukup signifikan. Stres pada pasien hipertensi umumnya disebabkan oleh kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan, ketakutan akan komplikasi, serta tuntutan menjalani pengobatan jangka panjang. Menurut Stuart (2016), stres merupakan respons individu terhadap tekanan yang dirasakan melebihi kemampuan coping yang dimiliki. Pada pasien hipertensi, stres dapat memicu peningkatan hormon stres seperti adrenalin dan kortisol yang berdampak pada peningkatan tekanan darah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh temuan bahwa sebagian besar responden merasa khawatir terhadap kondisi tekanan darah, takut mengalami komplikasi, serta terbebani dengan pengobatan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aspek psikologis merupakan bagian penting dalam pengelolaan hipertensi. Jika tidak

Comment [i-[28]: Minim sekali pembahasan

Comment [i-[29]: hapus

Comment [i-[30]: tambahkan %nya

ditangani, stres dapat memperburuk kondisi kesehatan serta menurunkan kualitas hidup pasien.

c. Berdasarkan kepatuhan pengobatan

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki kepatuhan pengobatan kategori tinggi yaitu sebanyak 14 orang (46,7%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien telah memiliki kesadaran yang cukup baik dalam menjalani pengobatan. Kepatuhan ini terlihat dari perilaku pasien yang rutin mengonsumsi obat, mengikuti anjuran tenaga kesehatan, serta melakukan kontrol secara berkala.

Comment [i-[31]: hapus

Menurut Notoatmodjo (2018), kepatuhan pengobatan merupakan perilaku individu dalam mengikuti anjuran medis yang meliputi konsumsi obat, kontrol rutin, dan perubahan gaya hidup. Namun demikian, masih terdapat responden dengan kepatuhan sedang dan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa belum semua pasien memiliki konsistensi dalam menjalani pengobatan. Faktor yang memengaruhi ketidakpatuhan antara lain, lupa minum obat, kesibukan sehari-hari, kurangnya pemahaman, serta pengaruh kondisi psikologis seperti stres.

Comment [i-[32]: ?

Penelitian Burnier & Egan (2019) menyatakan bahwa sekitar 30–50% pasien hipertensi tidak patuh terhadap pengobatan, yang menjadi salah satu penyebab utama kegagalan pengendalian tekanan darah. Selain itu, penelitian Xu et al. (2022) juga menunjukkan bahwa pasien dengan tingkat stres tinggi cenderung memiliki kepatuhan pengobatan yang lebih rendah. Hal ini disebabkan karena stres dapat memengaruhi motivasi, konsentrasi, dan perilaku kesehatan pasien.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 30 responden pasien hipertensi,

diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan pengobatan dalam kategori tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan jumlah responden sebanyak 14 orang (46,7%) yang berada pada kategori kepatuhan tinggi. Sementara itu, responden dengan kepatuhan sedang berjumlah 9 orang (30,0%), dan responden dengan kepatuhan rendah sebanyak 7 orang (23,3%). Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien hipertensi telah menjalani pengobatan secara cukup teratur. Namun demikian, masih terdapat sebagian responden yang memiliki tingkat kepatuhan sedang dan rendah, yang mengindikasikan bahwa belum semua pasien sepenuhnya konsisten dalam menjalani pengobatan. Kondisi ini menunjukkan perlunya perhatian lebih dari tenaga kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pasien dalam menjalani terapi secara rutin guna mencegah komplikasi akibat hipertensi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kondisi psikologis pasien berhubungan dengan kepatuhan pengobatan pada penderita hipertensi. Penelitian yang dilakukan oleh Xu et al. (2022) menunjukkan bahwa pasien hipertensi yang mengalami stres dan depresi memiliki kemungkinan lebih besar untuk tidak patuh terhadap pengobatan antihipertensi. Dalam penelitian tersebut dilaporkan bahwa sekitar 43% responden dengan tingkat stres tinggi menunjukkan kepatuhan pengobatan yang rendah, sedangkan pada kelompok pasien dengan tingkat stres rendah sebagian besar memiliki kepatuhan pengobatan yang lebih baik. Penelitian lain yang dilakukan oleh Burnier dan Egan (2019) juga menjelaskan bahwa ketidakpatuhan terhadap pengobatan antihipertensi masih cukup tinggi, yaitu sekitar 30–50% pasien hipertensi tidak menjalani terapi secara teratur, sehingga menyebabkan kegagalan dalam pengendalian tekanan darah. Selain itu,

Comment [i-[33]: Mengulang kalimat!

penelitian Saputri, Malasari, dan Rahman (2024) menunjukkan bahwa dari 60 responden pasien hipertensi yang diteliti, sebanyak 55% responden dengan tingkat stres tinggi memiliki kepatuhan minum obat rendah, sedangkan pada kelompok pasien dengan stres ringan sebagian besar memiliki kepatuhan yang lebih baik. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kondisi psikologis pasien menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi perilaku kesehatan, khususnya dalam kepatuhan terhadap pengobatan penyakit kronis seperti hipertensi (Xu et al., 2022; Burnier & Egan, 2019; Saputri et al., 2024).

Stres merupakan respons individu terhadap tekanan atau tuntutan yang dirasakan melebihi kemampuan coping yang dimiliki seseorang.. Pada pasien dengan penyakit kronis seperti hipertensi, stres dapat muncul akibat berbagai faktor, seperti kekhawatiran terhadap kondisi kesehatan, tuntutan pengobatan jangka panjang, perubahan gaya hidup, serta beban psikologis yang dialami pasien. Kondisi stres yang tidak dikelola dengan baik dapat memengaruhi fungsi kognitif dan emosional individu, sehingga dapat menurunkan motivasi serta kemampuan pasien dalam mempertahankan perilaku kesehatan yang adaptif, termasuk dalam kepatuhan mengonsumsi obat secara teratur (Stuart, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti berasumsi bahwa tingkat stres yang dialami pasien hipertensi di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo dapat memengaruhi kepatuhan pengobatan yang dijalani pasien. Pasien yang mampu mengelola stres dengan baik cenderung memiliki motivasi dan kesadaran yang lebih tinggi untuk mengikuti anjuran terapi secara teratur, sedangkan pasien dengan tingkat

stres yang tinggi cenderung mengalami penurunan motivasi dalam menjalani pengobatan secara konsisten.

Sementara itu, berdasarkan distribusi frekuensi jawaban pada kuesioner kepatuhan pengobatan, terdapat beberapa perilaku yang paling banyak dilakukan oleh responden. Tiga pernyataan dengan frekuensi tertinggi yaitu responden minum obat sesuai anjuran tenaga kesehatan sebanyak 24 responden (80,0%), responden berusaha minum obat secara teratur setiap hari sebanyak 23 responden (76,7%), serta responden melakukan kontrol kesehatan secara rutin sebanyak 21 responden (70,0%). Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien hipertensi telah berupaya menjalani pengobatan secara teratur, meskipun masih terdapat beberapa responden yang belum sepenuhnya patuh terhadap terapi pengobatan hipertensi.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi masih menjadi permasalahan yang cukup tinggi dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian yang dilakukan oleh Burnier dan Egan (2019) menyatakan bahwa sekitar 30–50% pasien hipertensi tidak patuh dalam menjalani pengobatan secara teratur. Ketidakpatuhan ini menjadi salah satu penyebab utama kegagalan dalam pengendalian tekanan darah dan meningkatkan risiko terjadinya komplikasi.

Selain itu, penelitian Xu et al. (2022) menunjukkan bahwa faktor psikologis seperti stres dan depresi memiliki hubungan yang signifikan dengan kepatuhan pengobatan. Pasien dengan tingkat stres yang tinggi cenderung memiliki kepatuhan yang lebih rendah dibandingkan pasien dengan tingkat stres ringan. Hal ini disebabkan karena

kondisi stres dapat memengaruhi motivasi, konsentrasi, serta kemampuan individu dalam menjalankan perilaku kesehatan secara konsisten.

Sejalan dengan penelitian tersebut, Putra dan Arisudhana (2021) menyatakan bahwa pasien yang memiliki dukungan keluarga yang baik dan tingkat pengetahuan yang tinggi cenderung lebih patuh dalam menjalani pengobatan. Sebaliknya, pasien yang kurang mendapatkan dukungan sosial serta memiliki tingkat stres yang tinggi cenderung menunjukkan perilaku tidak patuh terhadap terapi.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor medis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor psikologis, sosial, dan perilaku. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam meningkatkan kepatuhan pasien, termasuk melalui edukasi, dukungan keluarga, serta intervensi untuk mengelola stress.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa pengelolaan stres merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam pelayanan kesehatan pada pasien hipertensi. Upaya seperti edukasi kesehatan, konseling, serta dukungan psikososial dari tenaga kesehatan dapat membantu pasien mengelola stres dengan lebih baik sehingga kepatuhan pengobatan dapat meningkat dan pengendalian tekanan darah dapat tercapai secara optimal.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Comment [i-[34]: Tiap bagian di buat intinya saja!

a. Karakteristik Responden

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar responden pasien hipertensi berada pada kelompok usia 40–59 tahun, berjenis kelamin perempuan, dengan tingkat pendidikan terakhir SMA. Selain itu, mayoritas responden telah menderita hipertensi selama 1–5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hipertensi lebih banyak dialami oleh kelompok usia dewasa hingga lanjut serta cenderung terjadi pada responden dengan latar belakang pendidikan menengah.

b. Gambaran Tingkat Stres

Gambaran tingkat stres pada pasien hipertensi menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada kategori stres sedang, yaitu sebanyak 17 orang (56,7%). Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas pasien masih mengalami tekanan psikologis yang cukup signifikan, terutama berkaitan dengan kekhawatiran terhadap kondisi penyakit, kemungkinan komplikasi, serta tuntutan menjalani pengobatan jangka panjang.

c. Gambaran Kepatuhan Pengobatan

Gambaran kepatuhan pengobatan menunjukkan bahwa sebagian besar responden memiliki tingkat kepatuhan kategori tinggi, yaitu sebanyak 14 orang (46,7%). Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pasien telah berupaya menjalani pengobatan secara teratur sesuai anjuran tenaga kesehatan. Namun demikian, masih terdapat sebagian responden dengan tingkat kepatuhan sedang dan rendah, yang menunjukkan bahwa kepatuhan pengobatan belum sepenuhnya optimal pada

seluruh pasien hipertensi.

2. Saran

a. Bagi Tenaga Kesehatan

Comment [i-[35]: Puskesmas

Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan pelayanan secara komprehensif dalam pengelolaan pasien hipertensi, tidak hanya berfokus pada pengobatan farmakologis tetapi juga pada aspek psikologis pasien. Puskesmas dapat mengembangkan program edukasi rutin mengenai manajemen stres, konseling kesehatan, serta skrining tingkat stres secara berkala pada pasien hipertensi. Selain itu, integrasi program pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) dengan pendekatan promotif dan preventif perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas hidup pasien.

b. Bagi Perawat

Comment [i-[36]: Ilmu Keperawatan

Perawat diharapkan dapat melakukan pengkajian tingkat stres sebagai bagian dari asuhan keperawatan pada pasien hipertensi. Intervensi keperawatan tidak hanya berfokus pada pemantauan tekanan darah dan kepatuhan minum obat, tetapi juga pada pemberian edukasi, konseling, teknik relaksasi, serta penguatan mekanisme koping adaptif. Perawat juga perlu melibatkan keluarga dalam proses edukasi agar dukungan sosial pasien semakin optimal dalam meningkatkan kepatuhan pengobatan.

c. Bagi Pasien

Comment [i-[37]: Peneliti Selanjutnya

Pasien hipertensi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam mengelola stres melalui pola hidup sehat, aktivitas fisik teratur, teknik relaksasi, serta komunikasi yang baik dengan tenaga kesehatan. Pasien juga diharapkan lebih

disiplin dalam menjalani pengobatan, kontrol rutin, serta mengikuti anjuran medis untuk mencegah komplikasi yang lebih serius.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang lebih besar serta menggunakan desain analitik untuk mengetahui hubungan yang lebih signifikan antara tingkat stres dan kepatuhan pengobatan. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan menambahkan variabel lain seperti dukungan keluarga, tingkat pengetahuan, atau kualitas hidup pasien hipertensi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

American Heart Association. (2022). *Hypertension clinical guidelines*. American Heart Association.

Asmin, E., Tahitu, R., Que, B. J., & Astuty, E. (2021). Penyuluhan penyakit tidak menular pada masyarakat. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(3), 940-944.

Black, J. M., & Hawks, J. H. (2014). *Medical surgical nursing: Clinical management for positive outcomes*. St. Louis: Elsevier.

Brunner, L. S., & Suddarth, D. S. (2018). *Keperawatan medikal bedah*. Jakarta: EGC.

Comment [i-[38]: Cek kembali kesesuaian daftar pustaka!

Burnier, M., & Egan, B. M. (2019). Adherence in hypertension: A review of prevalence, risk factors, impact, and management. *Circulation Research*, 124(7), 1124–1140.

Carpenito, L. J. (2013). *Nursing diagnosis: Application to clinical practice*. Philadelphia: Lippincott.

Friedman, M. M. (2015). *Keperawatan keluarga: Teori dan praktik*. Jakarta: EGC.

Green, L. W., & Kreuter, M. W. (2015). *Health program planning: An educational and ecological approach*. New York: McGraw-Hill.

Hawari, D. (2016). *Manajemen stres, cemas, dan depresi*. Jakarta: FKUI.

Hidayat, A. A. A. (2017). *Metodologi penelitian keperawatan dan teknik analisis data*. Jakarta: Salemba Medika.

Keliat, B. A. (2015). *Keperawatan kesehatan jiwa komunitas*. Jakarta: EGC.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2018). *Laporan nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2019). *Pedoman pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023*. Jakarta: Kemenkes RI.
- Mustara, A., Hartono, D., & Pamungkasari, E. (2025). Psychological factors affecting medication adherence among hypertensive patients: A meta-analysis. *Nursing Journal*, 10(1), 15–25.
- Notoatmodjo, S. (2014). *Ilmu perilaku kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, S. (2018). *Metodologi penelitian kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nursalam. (2020). *Metodologi penelitian ilmu keperawatan*. Jakarta: Salemba Medika.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2017). *Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice*. Philadelphia: Wolters Kluwer.
- Putra, I. G. N., & Arisudhana, G. A. B. (2021). Hubungan tingkat stres dengan kepatuhan minum obat pada pasien hipertensi. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 15(2), 120–128.
- Ruswati. (2024). Peran keperawatan jiwa dalam meningkatkan kepatuhan terapi hipertensi. *Jurnal Keperawatan Jiwa*, 12(1), 33–40.
- Saputri, D., Malasari, R., & Rahman, A. (2024). Hubungan stres dengan kepatuhan pengobatan pada pasien hipertensi. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 27(1), 45–52.
- Smeltzer, S. C., & Bare, B. G. (2013). *Textbook of medical surgical nursing*. Philadelphia: Lippincott.
- Stuart, G. W. (2016). *Principles and practice of psychiatric nursing*. St. Louis: Elsevier.
- Telaumbanua, A. C., & Rahayu, Y. (2021). Penyuluhan dan edukasi tentang penyakit hipertensi. *Jurnal Abdimas Saintika*, 3(1), 119–124.

Townsend, M. C. (2014). *Psychiatric mental health nursing*. Philadelphia: F.A. Davis.

Videbeck, S. L. (2017). *Psychiatric mental health nursing*. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

World Health Organization. (2019). *Adherence to long-term therapies: Evidence for action*. Geneva: WHO.

**LEMBAR KUESIONER TINGKAT STRES DAN KEPATUHAN PENGOBATAN
PADA PASIEN HIPERTENSI**

A. Identitas Responden

1. Usia :
2. Jenis Kelamin :
 - ☐ Laki-laki
 - ☐ Perempuan
3. Pendidikan Terakhir :
 - ☐ SD
 - ☐ SMP
 - ☐ SMA
 - ☐ Perguruan Tinggi
4. Lama Menderita Hipertensi :
 - ☐ < 1 tahun
 - ☐ 1–5 tahun
 - ☐ > 5 tahun
5. Rutin kontrol ke Puskesmas :
 - ☐ Ya
 - ☐ Tidak

B. Tingkat Stres

(Sumber: Stuart, 2016; Hawari, 2016)

Petunjuk:

Berikan tanda (✓) pada jawaban yang sesuai dengan kondisi Anda.

Skor:

0 = Tidak pernah

1 = Kadang-kadang

2 = Sering

3 = Sangat sering

Kategori:

0–10 = Stres ringan

11–20 = Stres sedang

21–30 = Stres berat

No	Pernyataan	Skor 0	Skor 1	Skor 2	Skor 3
1	Saya merasa tegang atau gelisah				
2	Saya mudah marah				
3	Saya sulit tidur karena memikirkan penyakit				
4	Saya khawatir tekanan darah memburuk				
5	Saya merasa lelah secara mental				
6	Saya sulit berkonsentrasi				
7	Saya merasa terbebani dengan pengobatan				
8	Saya takut terjadi komplikasi				
9	Saya merasa putus asa dengan kondisi kesehatan				
10	Saya merasa tidak tenang menjalani aktivitas				

C. Kepatuhan Pengobatan

(Sumber: Notoatmodjo, 2018; WHO, 2019)

Petunjuk:

Berikan tanda (✓) pada jawaban yang sesuai.

Skor:

- Pernyataan positif → Ya = 1, Tidak = 0
- Pernyataan negatif (No. 2 & 3) → Ya = 0, Tidak = 1

Kategori:

7–8 = Kepatuhan tinggi

4–6 = Kepatuhan sedang

0–3 = Kepatuhan rendah

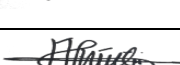
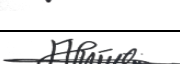
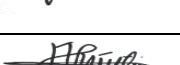
No	Pernyataan	Jawaban (Ya)	Jawaban (Tidak)
1	Saya minum obat setiap hari sesuai anjuran		
2	Saya pernah lupa minum obat		
3	Saya menghentikan obat saat merasa sehat		
4	Saya kontrol rutin sesuai jadwal		
5	Saya mengikuti diet rendah garam		
6	Saya tetap minum obat walau sibuk		
7	Saya minum obat sesuai dosis		
8	Saya merasa obat penting untuk kesehatan		

**GAMBARAN KARAKTERISTIK RESPONDEN KUESIONER TINGKAT STRES (S) dan KUESIONER KEPATUHAN
PENGOBATAN (K)**

Responden	Usia	jk	pendidikan	Lama HT	Rutin kontrol Ya/tidak	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	total	Kategori stres	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	total	Kategori kepatuhan
R1	<40	P	Smp	< 1th	Tidak	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10	S.ringan	0	0	0	1	1	1	1	1	5	K.sedang
R2	<40	P	Sma	1-5 th	tidak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	S.ringan	1	0	1	1	1	0	1	0	5	K. sedang
R3	<40	L	Sma	<1 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	17	S.sedang	1	1	1	0	1	1	1	1	7	K. tinggi
R4	<40	P	Sma	1-5 th	Tidak	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	S.ringan	0	1	1	0	1	0	0	1	4	K. sedang
R5	40-59	P	Smp	>5 th	Ya	2	2	2	1	1	1	2	1	1	1	14	S.sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K. Tinggi
R6	40-59	p	Sma	1-5 th	Ya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	S. ringan	0	0	0	0	1	0	1	0	2	K. rendah
R7	40 - 59	P	p. tinggi	>5th	Ya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	S. ringan	1	1	0	0	1	0	0	0	3	K. rendah
R8	40-59	P	p. tinggi	>5th	Ya	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	S. ringan	0	0	0	0	1	0	1	0	2	K. rendah
R9	40-59	L	p.tinggi	>5th	Ya	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	27	S. berat	1	0	0	0	1	0	0	0	2	K. rendah
R10	40-59	L	Sma	1-5 th	Ya	2	2	2	2	2	1	1	2	2	2	18	S. sedang	1	0	1	0	1	1	0	1	5	K. sedang
R11	40-59	L	Sma	<1 th	Ya	3	2	2	3	3	2	2	2	2	2	23	S. berat	1	1	1	0	1	1	1	1	7	K. sedang
R12	40-59	P	Sma	1-5 th	Ya	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	24	S. berat	1	0	0	1	1	1	1	1	6	K. sedang
R13	40-59	p	p.tinggi	>5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	S. sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K. tinggi
R14	40-59	P	p.tinggi	>5 th	Ya	2	2	2	1	2	2	1	1	1	1	15	S.sedang	0	0	0	0	1	0	0	1	2	K. rendah
R15	40-59	P	Smp	<1 th	Ya	1	2	2	1	1	2	1	1	1	2	14	S.sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K.tinggi
R16	40-59	P	Smp	1-5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	S.sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K tinggi
R17	40-59	L	Sd	1-5 th	ya	1	1	1	1	2	2	2	1	2	2	15	S.sedang	1	1	0	1	1	1	1	1	7	K. tinggi
R18	40-59	P	Sd	1-5 th	Tidak	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	14	S.sedang	0	1	1	0	1	1	1	1	6	.K sedang
R19	≥ 60	L	Sd	1-5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	24	S.berat	1	1	1	1	0	1	1	1	7	K. tinggi
R20	≥60	L	Smp	1-5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	19	S.sedang	1	0	1	1	1	1	0	1	6	K. sedang
R21	>60	p	Sd	1-5 th	Tidak	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	7	S.ringan	1	0	0	0	1	1	1	0	4	K. sedang
R22	>60	L	Sd	>5 th	Ya	2	2	3	2	3	2	3	3	2	1	23	S. berat	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K. tinggi
R23	>60	P	Smp	1-5 th	Ya	3	3	3	2	2	2	2	2	2	1	22	S. berat	1	0	1	1	1	1	1	1	7	K. tinggi
R24	>60	L	Smp	<1 th	Tidak	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	19	Ssedang	0	1	0	0	1	0	0	0	2	K. rendah
R25	>60	P	Sd	1-5 th	Tidak	2	2	1	1	2	2	2	1	2	2	17	Ssedang	1	0	0	0	1	0	1	0	3	K. rendah
R26	>60	P	Sd	1-5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	Ssedang	1	1	0	1	1	1	1	1	7	K. tinggi
R27	>60	P	Sd	1-5 th	Ya	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	18	S.sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K. tinggi
R28	>60	P	Sd	1-5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	20	S.sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K. tinggi
R29	>60	L	Smp	>5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	18	S.sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K. tinggi
R30	>60	L	Sma	>5 th	Ya	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	18	S.sedang	1	1	1	1	1	1	1	1	8	K. tinggi

LEMBAR KONSULTASI / BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yusmalinda
NIM : 2514201631
Program Studi : Sarjana Keperawatan
Pembimbing : Ns. Isti Harkomah, M. Kep
Judul Tugas Akhir : Gambaran Tingkat Stres dan Kepatuhan Pengobatan Pada Pasien Hipertensi dalam Program PTM di Puskesmas Rimbo Tengah Kab Bungo.

Bimbingan Ke :	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
I	Rabu, 01 april 2026	Konsul Judul Tugas Akhir	
II	Jumat, 03 april 2026	Konsultasi BAB I – BAB III	
III	Selasa, 14 april 2026	Perbaikan BAB I – BAB III	
IV	Minggu, 26 april 2026	Konsultasi Kuesioner	
V	Senin, 04 mei 2026	Perbaikan koesioner	
VI	Rabu, 06 mei 2026	Daftar riwayat hidup Riwayat hidup	
VII	Rabu, 06 mei 2026	Perbaiki pembahsan abstrak tambahkan dapusmya	
VIII	Rabu, 06 mei 2026	Lengkapi sesuaikan panduan TA Abstrak	
IX	Jumat, 08 Mei 2026	Perbaiki abstraknya Foto dokumentasi blur	
X	Sabtu, 20 Mei 2026	ACC Ujian TA	

DOKUMENTASI



**Pengisian kuesioner tingkat stres dan kepatuhan pengobatan
Pada pasien hipertensi**



**Pengisian kuesioner tingkat stres dan kepatuhan pengobatan
Pada pasien hipertensi**



**Pengisian kuesioner tingkat stres dan kepatuhan pengobatan
Pada pasien hipertensi**



**Pengisian kuesioner tingkat stres dan kepatuhan pengobatan
Pada pasien hipertensi**



**Pengisian kuesioner tingkat stres dan kepatuhan pengobatan
Pada pasien hipertensi**



**Pengisian kuesioner tingkat stres dan kepatuhan pengobatan
Pada pasien hipertensi**



**Pengisian kuesioner tingkat stres dan kepatuhan pengobatan
Pada pasien hipertensi**